

Fecha Última Actualización: 07-05-2023 5:30:53

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Ana Maria Perez Belmar

Edad : 56a 5m 29d

Dirección : Manuel Rodriguez 04686 Vista Hermosa

Rut : 10.591.049-5

Fecha Nacto: 08/11/1966

Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 9839248

Sexo : Femenino

Teléfono : 9 7690 0710

N° Epicrisis

352222

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/05/2023 07:25

Días Estadía : 2

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 07/05/2023 05:05

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Falla respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Ana Pérez Belmar
10.591.049-5
56 años

Tutor Martin (hijo) 930748441 y Nelson Cerda (marido) 959829116/976900710
Dueña de casa, vive con hijo y esposo.

ANTECEDENTES:

-Médicos:

·ERC V en HD por FAV -> tr renal el 25/03/22, requirió HD de forma transitoria post trasplante, luego con múltiples hospitalizaciones con interurrencias infecciosas, cardiovasculares, por lo que ha requerido HD transitorias y ha evolucionado progresivamente con falla renal del injerto, actualmente crea basal peri 2

·Pielonefritis injerto abril, mayo, junio 2022, KLPN BLEE, colección lecho quirúrgico de manejo médico con meropenem de forma prolongada. Febrero 2023 ITU por enterococo VAN B tratada con linezolid y PNA injerto en marzo 2023 por KLPN BLEE manejada con ertapenem

·Hospitalización por enterocolitis por CD Julio 2022, COVID leve 2023

·Cardiopatía Coronaria conocida al menos desde año 2021 con MIBI con insuficiencia de riego coronario. Coronariografía enero 2023 Enfermedad de tres vasos (ADA lesión larga, ACx crónica, ACD severamente enferma) y EcoCardio 01/02/23 con FEVI 60%, dilatación biauricular e hipertensión pulmonar leve. Manejo médico. Evidencia de infarto tipo II al menos en hospitalizaciones de enero, febrero y abril 2023. El 19/04 se realiza coronariografía con instalación de stent medicado en tercio proximal de arteria coronaria derecha

·Enfermedad péptica: Úlceras Forrest III bulbo duodenal Abril 2023 (shok hemorrágico, IAM tipo II)

·DM con daño de órgano blanco (retinopatía diabética proliferativa, nefropatía)

·HTA, DLP, Artrosis

-Quirúrgicos: Trasplante renal DC injerto a FID° (25/03/22) - Retiro doble J (10/05/22) - FAV ES I° , colecistectomía, FACO bilateral

-Medicamentos: Tacrolimus 2.5 mg/12h, prednisona 5 mg /día, Ácido acetilsalicílico 100 mg/día, Clopidogrel 75 mg/día, Atorvastatina 80 mg/día, Carvedilol 6.25 mg c/12 h, Hidralazina 25 mg c/8 h, Furosemida 40, Nitrofurantoina 100 mg/día, Bicarbonato de sodio 1 g c/12, toujeo, novorrapid, everolimus, Isosorbide, Amlodipino, Cotrimoxazol forte, carbonato de calcio

-Alergias: (-)

Fecha Epicrisis : 07/05/2023 05:30

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 07-05-2023 5:30:53

Página 2 de 2

-Hábitos: Tabaquismo 4 cig/día (refiere suspendido desde trasplante renal), OH (-), drogas (-).

Ingresa el 5/5 al hospital por cuadro de 1 semana de evolución de disnea progresiva, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Refiere que en los últimos días ha notado orina turbia y de mal olor. Al examen físico destacan crépitos pulmonares, edema de extremidades e ingurgitación yugular. Ecoscopia VCI dilatada sin variabilidad, líneas B en pulmón, derrame pleural. Sin signos de isquemia actual al ECG. Al laboratorio con elevación de parámetros inflamatorios, sedimento de orina inflamatorio, exacerbación de falla renal con crea >3 y BUN >70, hiperkalemia severa, acidosis metabólica y anemia severa con Hb<7 que se transfunde.

TC TAP evidenció moderado derrame pleural bilateral. Atelectasias segmentarias bibasales. Opacidades parenquimatosas bilaterales descritas compatibles con edema pulmonar alveolar ¿ Intersticial o neumopatía aguda multifocal infecciosa. Acentuada cardiomegalia. Injerto renal en FID con engrosamiento cortical y leve hidronefrosis.

Evoluciona en regulares condiciones generales, hipotensa y febril, se prueba VNI por 24 hrs, pero luego con respiración paradójica por lo que se decide intubación y conexión a VMI el 6/5, con apoyo de ADN hasta 0.25 ug/kg/min. Se transfunde GR con Hcto control 48%, se inician antibióticos (imipenem + vancomicina) y medidas hipokalemiantes con escasa respuesta, presentando bradicardia al monitor por lo que se decide diálisis de urgencia por FAV braquial. Posterior a TRR se controlan exámenes que evidencian K 3.4, BUN 20, sin acidosis metabólica. Ingresa a UPC a las 3 am, paciente posterior a cambio de cama con hipotensión subita, taquicardia sinusal al monitor y posterior PCR en asistolia. iSTAT con GSA sin acidosis ni hipoxemia ni hipoglicemia, kalemia 5, Hcto 20% con TR (-), escasa salida de contenido hemático por SNG, ecoscopia sin líquido libre abdominal ni torácico ni derrame pericárdico, sin dilatación de cavidades derechas, sin neumotórax. Se inician maniobras avanzadas de reanimación, aporte de gluconato de calcio, sulfato de magnesio, volemicación con 500 cc albúmina al 4%, 1000 cc SF, 500 cc NaHCO3 2/3 M, transfusión de 4 U GR, 8 U PFC, 8 U CPP, 8 U plaquetas por sospecha de sangrado activo, ROSC a los 24 minutos, con apoyo de NE 1,4 ug/kg/min. Ritmo de salida taquicardia sinusal, con infradesnivel del ST marcado. Evolucionando con pausas sinusales, TV con pulso, se cardiovierte en 3 oportunidades, se administran 300 mg de amiodarona, infusión de sulfato de magnesio (5 ampollas) y lidocaina pero evoluciona con torsión de puntas que requiere 2 CVE y posteriormente PCR en asistolia nuevamente, falleciendo a las 04:55 del 07/05/2023.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica -
Shock séptico -
Shock hipovolémico -
Shock cardiogénico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece a las 04:55 del 7/5

Plan Post Alta

Se entrega certificado de defunción y se traslada a anatomía patológica

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Maria Celis Le Roy
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 07/05/2023 05:30

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:38

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar